

INDICADO POR: filhas

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231697075 | 925**MARIA JOSEILDE MENEZES DE ANDRADE**IDADE: 59 PESO: 110 ALTURA: 1,55 PROFISSÃO: limpezaSINTOMAS: Dorco e Engasgo presenciados, sonolência diurna
causado

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Vai iniciar medicamento HASMÉDICO: Dr. Rafael Ozorio

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x pilates / 2x musculaçãoHORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 20:30hHORA QUE DORME: 23:30 - 0h HORA QUE ACORDA: 6h - 8h

COCHILHO () S (X) N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: normal BANHEIRO/NOITE: 1 - 2xCIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: afetada CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 76,4 SPO2: 60%PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Pneumonia latente, HAS

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

12/11/24 Associação Locação Maxe Swift Fx (M)19/11/24 Fixo pressão em 10cmH2O21/11/24 P=10cmH2O
IAH=2,3 elev Bem adaptada
m de uso: 8h4'
fuqpi: 0 Natacha12/12 P=10cmH2O
24 IAH=1,6 elev
m. de uso: 7h
fuqpi=1,6 elev

05/12
24 $P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,4 \text{ e/h}$
m de uso: 6h12'
fuga: 0,9 l/m

Bem adaptada
Natacha

08/01
25 $P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,3 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h38'
fuga: 4,4 lpm.

- melhora do quadro de refluxo

duas claudicações

14/02/25 $P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,1 \text{ e/h}$
m de uso: 6h59'
fuga: 3,6 l/m

Bem adaptada
Natacha

15/04
25 $P = 10 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $IAH = 1,0 \text{ e/h}$
m de uso: 6h43'
fuga: 4,1 l/m

Bem adaptada

Natacha

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: MARIA JOSELEDE MENEZES DE ANDRADE

Sexo: Feminino

Data do Exame: 01-11-2024

Idade: 59 anos

Peso: 110 kg

Altura: 1,51 m

Médico Solicitante: DR. RAFAEL OZORIO ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 01/11/2024 21:01 e finalizado às 02/11/2024 05:45.

A latência para início do sono foi de 19,0 min e a latência para o sono REM de 305,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 487,5 min, com eficiência do sono de 93,7 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 3,1 % de estágio N1, 72,3 % de estágio N2, 13,8 % de estágio N3 e 4,8 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 13,7 min. Ocorreram 698 despertares, sendo o índice de 80,5 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 621, sendo 3 apneias obstrutivas, 2 apneias centrais, 4 apneias mistas, 612 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 76,4 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 46,0 e o IDR durante o sono NREM foi de 78,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 76,4 (nº/h), sendo 1,1 apneia/h e 75,3 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 91%, a média de 86% e a mínima de 60%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 90,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 102,1 (nº/h) e em NREM foi de 96,6 (nº/h). Permaneceu 52,1 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**76,4 n°/h**) aumentado predominando os eventos respiratórios obstrutivos (VN= até 5 n°/h);
2. Presença de dessaturação da oxi-hemoglobina associado aos eventos respiratórios anormais;
3. Latência para o início do sono normal diminuída (**19,0 min**) (VN= até 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**305,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono normal (**93,7 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Aumento do índice de despertares **80,5 (n°/h)** (VN= até 15 n°/h);
7. Diminuição do percentual do estágio N1 (**3,1 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**19,8 %**) (VN= 13% a 23%);
9. Diminuição do Percentual do estágio REM (**4,8 %**) (VN= 20% a 25%);
10. Ronco intenso e constante verificado via sensor de ronco durante a leitura do exame;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrões de normalidade para crianças até 17 anos: IDR até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

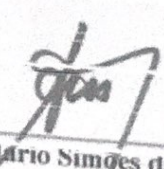
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MARIA JOSEILEDE MENEZES DE ANDRADE

Data do Exame: 01/11/2011